



# AUTO EVALUATION – Q.C.M.

# *Cas clinique QCM1 :*

Monsieur M., 58 ans, présente depuis quatre semaines et suite au décès de sa femme, une insomnie avec des réveils matinaux précoces.

Il se plaint d'être fatigué et dit ne plus s'intéresser à la lecture comme auparavant avec des oublis fréquents.

A l'entretien, des crises des larmes interrompent son discours.

L'examen physique est normal.

CCQ1- Quels sont les symptômes retrouvés dans cette observation :

A- Tristesse

B- Ralentissement moteur

C- Dévalorisation

D- Persécution

E- Insomnie d'endormissement

CCQ3- Le diagnostic de dépression a été retenu, quelle est la principale indication thérapeutique ?

- A- Antidépresseur + thymorégulateur
- B- Antidépresseur + neuroleptique déshinibiteur
- C- Antidépresseur + Psychothérapie
- D- Antidépresseur + traitement étiologique
- E- Abstention thérapeutique

**CCQ4- Le délai d'action de la médication  
antidépressive est de :**

- A- Une semaine
- B- Deux semaines
- C- Trois semaines
- D- Quatre semaines
- E- Cinq semaines

# AUTO EVALUATION – Q.C.M.

**1- Parmi les symptômes suivants, lesquels se rencontrent dans un état dépressif :**

A. La bradypsychie

B. L'amivalence

C. L'insomnie

D. La désinhibition

E. L'absence d'initiative

## 2- Le syndrome dépressif comporte :

- A. Le ralentissement psychomoteur
- B. L'abaissement de l'humeur
- C. La désorientation
- D. La logorrhée
- E. Le délire



**5- Chez un malade déprimé, parmi les éléments du risque suicidaire, on retient :**

- A. L'isolement social
- B. La sévérité de la dépression avec désespoir
- C. Le sexe féminin
- D. L'importance du ralentissement moteur
- E. La préméditation de l'acte

## 8- Le traitement par le sel de lithium :

- A. a comme indication majeure la prévention des accès maniaques et / ou dépressifs du trouble bipolaire
- B. nécessite une surveillance régulière de la fonction rénale
- C. Est efficace à une posologie en fonction du poids
- D. ne peut être utilisé en association avec les antidépresseurs
- E. nécessite un régime sans sel strict.

12- Parmi les chimiothérapies suivantes, lesquelles sont susceptibles d'engendrer une dépression symptomatique

- A. La cimétidine (Tagamet®)
- B. L'isoniazide (Rimifon®)
- C. La carbamazépine (Tégréto®)
- D. L'halopéridol (Haldol®)
- E. L'alpha-méthyldopa (Aldomet®)

**13- La gravité de l'état dépressif s'évalue par :**

- A. La présence d'idées délirantes
- B. L'importance du ralentissement moteur
- C. L'importance des facteurs de stress
- D. L'absence d'amélioration de l'humeur par la réassurance
- E. Le risque suicidaire

**15- Parmi les symptômes suivants, lesquels sont typiques d'un accès maniaque :**

- A. Perplexité anxieuse
- B. Excitation psychique
- C. Hallucinations auditives
- D. Excitation motrice
- E. Excitation instinctuelle

**16- Parmi les symptômes suivants,  
le(s)quel(s) caractérise(nt) la fureur  
maniaque :**

- A. Une labilité de l'humeur
- B. Une altération de l'état général
- C. Des passage à l'acte agressif fréquents
- D. Un obscurcissement de la conscience
- E. Agitation psychomotrice extrême

## **17-Concernant l'accès hypomaniaque, les propositions suivantes sont justes:**

- A. Peut passer inaperçu
- B. Constitue en s'associant à des épisodes dépressifs majeurs le trouble bipolaire type I
- C. Est incompatible avec une bonne adaptation socioprofessionnelle
- D. Est une forme atténuée de l'accès maniaque
- E. Constitue un facteur de risque de suicide

## 18-Concernant la manie délirante, les propositions suivantes sont justes:

- A. Les thèmes délirants de grandeur et de toute puissance sont fréquents
- B. Le mécanisme hallucinatoire du délire est fréquent
- C. Le délire peut être congruent ou non congruent à l'humeur
- D. l'accès maniaque peut être d'intensité légère ou modérée
- E. l'excitation psychomotrice est moins importante



**19- Concernant l'accès maniaque, les symptômes suivants sont considérés comme des critères de mixité selon le DSM 5:**

- A. Une labilité de l'humeur
- B. La dysphorie
- C. La diminution des intérêts et des plaisirs
- D. l'ambivalence affective
- E. l'humeur dépressive

## 20- Concernant les modalités évolutives des troubles bipolaires de l'humeur:

- A. Le nombre d'accès tend à diminuer avec l'âge
- B. La récurrence est une caractéristique fondamentale des troubles bipolaires
- C. le cycle de la maladie est la durée de l'intervalle entre deux épisodes maniaques
- D. Les cycles ne subissent pas d'influence saisonnière
- E. Les cycles rapides sont caractérisés par la survenue d'au moins 4 accès thymiques en une année

# Cas clinique

## QCM 2 .

**Monsieur M. âgé de 23 ans est amené aux urgences après une tentative de suicide par raticide, il a été trouvé par hasard par sa sœur aînée, qui l'avait trouvé inconscient dans sa chambre, il avait aussi laissé une lettre d'adieu dans laquelle il expliquait son geste par un désespoir, une vision noire de l'avenir, il n'avait plus aucune raison de vivre d'après ses dires, il voulait rejoindre son oncle, suicidé lui-même 8 ans auparavant, l'oncle était suivi pour un trouble bipolaire .**

L'examen psychiatrique fait après la stabilisation de son état somatique révèle une tristesse importante ressentie comme active, véritable douleur morale, Mr. Rapporte que depuis 1 mois, il ne veut plus rien faire, même pas ses habituelles parties de pêche avec ses amis, il paraît asthénique, ses gestes sont lents, sa mimique est peu expressive, il avait du mal à maintenir son attention pour l'entretien et il avait des troubles du sommeil, il se réveillait tous les jours à 4 h du matin sans pouvoir se rendormir. Il vous dit qu'il porte malheur à tous ceux qu'il approche, c'est d'ailleurs à cause de lui que ses parents ont divorcé, que tous les couples de la ville ont divorcé et qu'il y a, en général, tant de malheur dans cette ville, il le sent dans le regard des gens. Par ailleurs, il vous dit clairement qu'il regrette qu'il se ne soit pas mort.

**1- Après une analyse sémiologique de ce cas clinique, vous retenir :**

- A. Un syndrome délirant
- B. Un syndrome dissociatif
- C. Un syndrome dépressif
- D. Un syndrome anxieux
- E. Un syndrome maniaque

**2- Les facteurs de risque de persistance de la crise suicidaire sont :**

- A. Antécédent de suicide de l'oncle
- B. Le syndrome dépressif grave
- C. La lettre d'adieu
- D. Le ralentissement psychomoteur
- E. L'absence de regret de la tentative à l'examen

**2- Les facteurs prédictifs de bipolarité sont :**

- A. Antécédent de trouble bipolaire chez l'oncle
- B. L'âge
- C. Le sexe masculin
- D. La tentative de suicide
- E. Les caractéristiques psychotiques



**Deux jours plus tard, vous rencontrez la mère de Mr. M, qui vous raconte que pendant un voyage deux ans auparavant, il a présenté une période d'agitation, avec excitation psychomotrice importantes ayant nécessité son hospitalisation pendant deux semaines puis mis sortant, mais n'est pas revenu pour le suivi.**

**3- En tenant compte de ces nouvelles informations, vous retenez le diagnostic de :**

- A. Trouble bipolaire I
- B. Trouble bipolaire II
- C. Trouble dépressif majeur récurrent
- D. Trouble schizoaffectif
- E. Trouble dépressif persistant

**4- Pour traiter l'épisode actuel, les possibilités thérapeutiques suivantes peuvent être envisagées :**

A. Lamotrigine

B. Lithium+ un antidépresseur ISRS

C. Lithium+ un antidépresseur tricyclique

D. Antipsychotique atypique+ un antidépresseur ISRS

E. Neuroleptique classique seul

**5- Pour le traitement à long terme, les alternatives suivantes peuvent être envisagées :**

- A. Antidépresseur seul
- B. Lithium seul
- C. Antipsychotique atypique seul
- D. Neuroleptique classique seul
- E. Acide valproïque seul

# Cas clinique QCM 3 .

**Madame AB, 50 ans femme au foyer est amenée aux urgences psychiatriques. Depuis quelques semaines, elle se sent très fatiguée et a de plus en plus de problèmes pour se concentrer. Elle a perdu l'appétit et a maigri de 7 kilos. Elle a des difficultés pour s'endormir et se réveille à 3 heures du matin. Lors de l'entretien, elle est figée. Son discours est monotone et lent. Vous la trouvez abattue. Elle pense avoir commis des erreurs graves dans l'éducation de ses enfants, les mettant de ce fait en danger. Elle vous dit : « Je ne suis plus bonne à rien, je suis une incapable, une mère et une épouse indigne.. ».**

**Son mari vous apprend qu'il ya 20 ans, elle « avait fait une petite bêtise... elle avait pris trop de médicaments... ». Il vous signale aussi que son père s'est pendu et que sa mère souffre d'une maladie de Parkinson.**

## 1 - Madame AB présente :

- A- Une désorientation temporo-spatiale.
- B- Un délire de persécution.
- C- Un ralentissement moteur.
- D- Une vision négative de soi.
- E- Une baisse de l'humeur.

**2- Le diagnostic d'épisode dépressif caractérisé est retenu, quels antidépresseurs peuvent être utilisés en première intention**

A- Venlafaxine

B- Clomipramine

C- Paroxétine

D- Escitalopram

E- Amytriptyline



**- Parmi les antidépresseurs suivants, lesquels appartiennent à la famille des ISRS**

A- Venlafaxine

B- Clomipramine

C- Paroxétine

D- Fluoxétine

E- sertraline

## - La mélancolie puerpérale

A- survient 6 mois à un an après l'accouchement

B- est une forme grave de dépression du post partum

C- le risque d'infanticide est extrême

D- le risque de suicide est faible

E- l'évolution vers le trouble bipolaire est fréquente

